

SÉMIOLOGIE DES PÉRICARDITES

Université de Constantine

Faculté de médecine

3eme année de médecine

Module de sémiologie cardiovasculaire

Dr.Z.Bouachiba

Maitre assistante

Service de médecine interne EHDMC

Objectifs pédagogiques:

1. Identifier les manifestations cliniques évocatrices d'une péricardite aiguë.
2. Décrire et interpréter les anomalies électrocardiographiques caractéristiques.
3. Établir le diagnostic de péricardite aiguë en combinant les données cliniques, biologiques et échographiques.
4. Connaître les principales causes (étiologies) des péricardites aiguës.
5. Reconnaître les complications majeures et les signes de gravité.
6. Déterminer les indications d'hospitalisation et de prise en charge spécialisée.

Plan du cours

1. Définition
2. Anatomie & rappel physiologique
3. Sémiologie clinique
4. Examens complémentaires
5. Diagnostic différentiel
6. Étiologies

7. Critères de gravité et pronostic
8. Complications (tamponnade – constriction)
9. Traitement
10. Références

1. Définitions

La **péricardite aiguë** est une inflammation du péricarde, avec ou sans épanchement. Elle constitue une urgence diagnostique du fait du risque de **tamponnade** et du risque évolutif vers la **péricardite constrictive**.

Classification:

Type	Définition
Aiguë	Symptômes < 4-6 semaines
Incessante	Symptômes persistants sans rémission > 4-6 semaines
Récurrente	Récidive après une rémission > 4-6 semaines
Chronique	> 3 mois

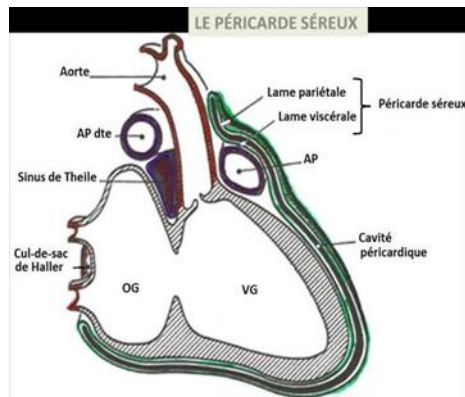
NB: Le **volume** de l'épanchement ne prédit pas la gravité autant que la **rapidité d'installation**. La **tamponnade** peut survenir même avec un épanchement modéré.

2. Anatomie du péricarde

Le péricarde comporte :

- **1. Péricarde fibreux** (externe)
- **2. Péricarde séreux** comprenant :
 - feuillet **pariétal**
 - feuillet **viscéral** (épicarpe)

Entre les deux : **cavité péricardique** contenant normalement **15–60 mL** de liquide clair.



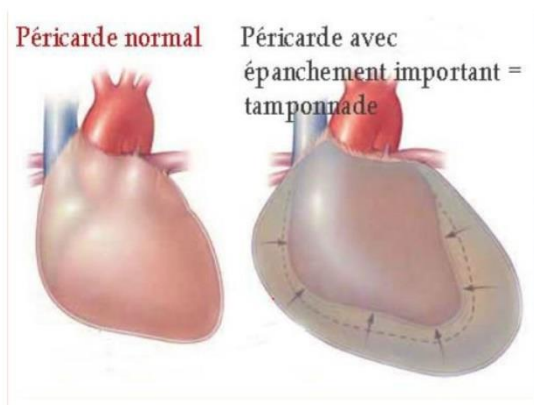
2.1. Anatomie pathologique

Péricardite sèche

- Feuillet rugueux, congestifs.
- Frottement péricardique fréquent.
- Douleur marquée.

Péricardite avec épanchement

- Liquide : citrin, hémorragique, sérohématique, purulent.
- Quantité : 300 mL à 2 L.
- Peut être cloisonné.



3. Sémiologie clinique

3.1. Signes fonctionnels

1. Douleur thoracique (symptôme majeur)

Caractéristiques typiques :

- Siège : médiastin thoracique ou rétro-sternal
- Type : piqures, brûlures, parfois pseudo-angineuse
- **Augmentée par** : toux, inspiration profonde
- **Améliorée par** : antéflexion, AINS
- **Non soulagée par** : dérivés nitrés

2. Dyspnée

- Modérée
- Soulagée par la position penchée en avant

3. Signes associés possibles

- Dysphagie
- Dysphonie
- Hoquet (atteinte phrénique)

3.2. Signes généraux

- Fièvre modérée
- Syndrome pseudo-grippal
- Asthénie, myalgies
- Amaigrissement si cause chronique ou tuberculeuse

3.3. Signes physiques

1. Frottement péricardique (signe pathognomonique)

- Bruit superficiel, râpeux, “crissement de cuir neuf”
- Persiste en apnée
- Fugace, peut disparaître

2. Autres signes

- Choc de pointe atténué
- Bruits du cœur assourdis
- Tachycardie
- Signes d'insuffisance cardiaque droite si épanchement important

4. Examens complémentaires

4.1. Radiographie thoracique

Signes en faveur d'un épanchement important :

- Silhouette cardiaque élargie
- Rectitude du bord gauche
- Aspect en **carafe**
- Effacement des angles cardio-phréniques

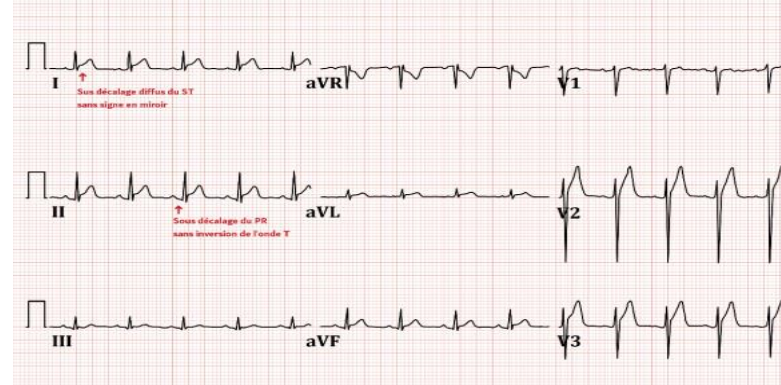
4.2. ECG

Évolution en **4 stades de Holzmann** :

Stade	Durée	Aspect
I	< 24 h	Sus-décalage ST concave diffus + sous-décalage PQ
II	< 48 h	Retour ST isoélectrique, T plates
III	< 7 j	Inversion ondes T
IV	< 60 j	Normalisation

Signes additionnels :

- Microvoltage
- Alternance électrique (épanchement abondant)
- Troubles du rythme supraventriculaire



4.3. Échocardiographie

Examen clé permet de :

- Confirmer l'épanchement
- Mesurer son abondance
- Dépister signes de tamponnade
- Guider la ponction péricardique
- Rechercher signes de constriction

4.4. Biologie

- CRP, VS : élevées
- Troponine légèrement augmentée si myo-péricardite
- NFS (infection – néoplasie)
- Créatinine (péricardite urémique)

5. Diagnostic différentiel

Diagnostic	Points discriminants
Infarctus	ST sus-décalé convexe, ondes Q, troponines très élevées
Embolie pulmonaire	Dyspnée brutale, S1Q3T3, D-dimères, angioscanner
Dissection aortique	Douleur déchirante, asymétrie tensionnelle
Pneumopathie / pleurésie	Fièvre, râles, condensation

6. Étiologies:

6.1. Infectieuses

- **Virales (+++)** : Influenza, Cocksackie, EBV, CMV
- **Bactériennes** : *Staphylococcus*, pneumocoque, tuberculose
- **Fongiques** (immunodéprimés) : Candida, Aspergillus
- **Parasites** : Échinocoque

6.2. Auto-immunes / inflammatoires

- Lupus
- PR
- Gougerot-Sjögren
- Sclérodermie
- Maladie de Behçet
- Vascularites (Churg-Strauss, Takayasu)

6.3. Métaboliques

- Urémie
- Myxœdème
- Anorexie sévère

6.4. Néoplasiques (35 % des péricardites secondaires)

- Métastases pulmonaires
- Cancers mammaires
- Lymphomes

6.5. Post-lésionnelles

- Post-infarctus précoce
- Syndrome de Dressler
- Post-radique
- Post-chirurgie cardiaque (25 %)

7. Critères de gravité (ESC)

Critères majeurs

- Fièvre > 38°C
- Tamponnade

- Début subaigu
- Épanchement abondant
- Non-réponse aux AINS après 7 jours

Critères mineurs

- Immunodépression
- Traumatisme
- Anticoagulants
- Myo-péricardite

8. Complications

8.1. Tamponnade cardiaque

Urgence vitale

Signes cliniques :

- TA effondrée
- Turgescence jugulaire
- Tachycardie
- Pouls paradoxal

ECG:

- Microvoltage
- Alternance électrique

Écho :

- Épanchement abondant
- Collapse OD/VD
- Cœur “dansant” ou swining heart

Traitement :

→ **Drainage péricardique en urgence**

8.2. Péricardite constrictive

- Dilatation veineuse jugulaire
- Pouls paradoxal de Kussmaul
- Ascite prédominante
- Calcifications péricardiques au scanner

9. Traitement (selon la cause)

Péricardite aiguë idiopathique / virale

- **AINS** 1–2 semaines
- **Colchicine** 3 mois
- **Repos strict**
- Éviter corticoïdes (favorisent les rechutes)

Tuberculose

- Quadrithérapie 6 mois
- Corticoïdes si large épanchement

Purulente

- Antibiothérapie IV
- Drainage péricardique

Néoplasique

- Drainage
- Traitement oncologique

10. Références

1. ESC 2015 Guidelines for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases
2. Braunwald's Heart Disease
3. Polycopié de sémiologie cardiovasculaire – CNEC